

소 속, 성 명 대전충청본부 □부 HHH 팀장

제 목 물리치료 인정비율 심사 자동화(RPA) 개발로 심사 효율성 및 정확성 제고

내 용

1. 추진배경

현재 물리치료 인정비율 심사는 의료기관 인력·청구현황·급여기준 등을 고려하여 수작업 방식으로 1차심사¹⁾와 사후심사²⁾로 이원화하여 운영하고 있어 심사효율성 및 정확성 저하로 사후심사 일원화 및 업무처리자동화(RPA) 발굴 및 적용이 필요하다.

2. 추진내용

업무의 효율성 및 정확성 제고를 위해 물리치료 인정비율을 자동으로 산출해주는 RPA시스템을 관련부서(경영정보부)와 협업하여 개발 중에 있다. '25년 9월 개발 착수, 10월 검증 및 모니터링, 11월부터 '25년 1월 진료 분을 대상으로 사후심사 방식으로 일괄 적용 예정이다.

3. 추진성과

물리치료 인정비율 심사 자동화(RPA)를 전 본부 확산 시 연간 업무 시간 약 15,400시간 단축 및 인건비 약 4억8천만 원(주30시간 12명) 절감 효과가 있다. 아울러 '24년 기준 재정절감액은 약 15억 원이었고, 심사 자동화(RPA)로 누락 없이 신속하고 정확한 심사가 기대된다.

1) 청구시점(주단위, 월단위)별로 물리치료 횟수 합산하여 인정비율 산출 적용

2) 진료연월별 보험자별 인정비율 상이 및 정산 누락분에 대해 사후정산

[표 8] RPA 개발 전·후 비교

구분	AS-IS: 수작업(인력)	TO-BE: 자동화(RPA)
심사 방법	심사 이원화(1차심사 + 사후심사)	심사 일원화(사후심사)
처리 시간	대전충청본부 연간 1,296시간	대전충청본부 연간 12시간
	(1차심사) 20분*15명*20일*12개월=1,200시간 (사후심사) 8시간*2명*3일*2번=96시간	(사후심사) 1시간*1명*1일*12개월=12시간
	* 12본부: 15,552시간	* 12본부: 144시간
심사 주기	(1차심사) 매일 & (사후심사) 반기별	(사후심사) 월별
인건비 절감효과	-	주30시간 심사자 12인 (총 4억8천만 원)

4. 향후 추진계획

물리치료 인정비율 심사 자동화(RPA) 시스템의 원활한 구축을 위해 관련부서와 협업하여 지속적으로 보완 후 현업에 적용, 전사확대 실시할 계획이다. 또한, 물리치료 인정비율 심사 자동화 성과는 경영평가지표인 심사사후관리 재검검 항목으로 활용 가능할 것으로 보인다. 추후 가정간호 기본방문료 인정비율 심사 등 RPA 적용 가능여부를 검토하여 심사 효율성 및 정확성 제고할 예정이다.

[별표 1]

2024년 본부별 물리치료 청구 및 조정현황

◆ 산출 조건
▪ 요양개시연월: 2024년 ▪ 심사연월: 2024.01-2025.02 ▪ 보험자 전체 ▪ 지급구분코드: 1
▪ 심사조정사유코드: BR(물리치료 1일 산정횟수 초과분 조정)
◆ 항목별 수가코드
- (의과) MM010, MM011, MM012, MM015, MM020, MM030, MM041, MM042, MM043, MM044, MM045, MM046, MM047, MM048, MM049, MM051, MM052, MM060, MM070, MM080, MM085, MM090, MM101, MM102, MM103, MM151, MM170, MM190, MM290, MM301, MM302, MX121
- (한방) 40700, 40701, 40702

(단위: 천건, 백만원, %)

본부 코드	본부 명칭	청구(A)			조정(B)		조정률(B/A)	
		명세서 건수	청구총액	물리치료	건수	금액	건율 ¹⁾	액률 ²⁾
계		146,555 (100.0)	15,081,911 (100.0)	1,372,964 (9.1)	3,214 (100.0)	1,525 (100.0)	2.19	0.11
01	서울	30,074 (20.5)	2,595,597 (17.2)	243,221 (9.4)	540 (16.8)	214 (14.0)	1.80	0.09
02	부산	11,438 (7.8)	1,507,660 (10.0)	113,665 (7.5)	249 (7.7)	82 (5.4)	2.18	0.07
03	대구 경북	13,710 (9.4)	1,552,895 (10.3)	146,570 (9.4)	267 (8.3)	111 (7.3)	1.95	0.08
04	광주 전남	9,886 (6.7)	1,297,827 (8.6)	104,875 (8.1)	244 (7.6)	286 (18.8)	2.47	0.27
05	대전 충청	16,196 (11.1)	1,456,513 (9.7)	141,018 (9.7)	369 (11.5)	188 (12.3)	2.28	0.13
06	경기 남부	25,466 (17.4)	2,499,203 (16.6)	231,474 (9.3)	513 (16.0)	197 (12.9)	2.01	0.09
07	울산 경남	11,693 (8.0)	1,310,862 (8.7)	116,076 (8.9)	318 (9.9)	134 (8.8)	2.72	0.12
08	경기 북부	9,889 (6.7)	1,040,670 (6.9)	95,880 (9.2)	209 (6.5)	93 (6.1)	2.11	0.10
09	전북	6,566 (4.5)	638,168 (4.2)	64,467 (10.1)	237 (7.4)	117 (7.7)	3.61	0.18
10	인천	8,066 (5.5)	899,846 (6.0)	85,436 (9.5)	148 (4.6)	49 (3.2)	1.83	0.06
11	강원	2,194 (1.5)	192,692 (1.3)	19,555 (10.1)	66 (2.1)	29 (1.9)	3.01	0.15
12	제주	1,377 (0.9)	89,978 (0.6)	10,727 (11.9)	54 (1.7)	25 (1.6)	3.92	0.23

주: 1. 건율: 조정명세서건수/청구명세서건수 * 100
2. 액률: 물리치료 조정금액/물리치료 청구액 * 100

[별표 2]

업무처리자동화(RPA) 인건비 절감효과

- 심사자 1인 연간 근무(A) = 8시간 * 20일 * 12개월 = 1,920시간
- 물리치료 RPA 소요공수(B) = 1,296시간(연간심사자 단축시간)
- 본부당 인건비 절감 인원 = B/A $\approx$ 0.7명(주30 심사자 1인)
- 본부당 절감금액 = 절감인원 * 1인 연봉 = 주30근무 심사자 1인 * 4천만원 = 4천만원
- 전 본부 절감금액 = 본부당 절감금액 * 12 본부 = 4천만 원 * 12 = 4억8천만 원